



251029044

807 高雄市三民區察哈爾二街31號11樓

葉興松先生

目錄 (Catalogue)

項目 (Category)	頁次 (Page)
綜合分析(Summary).....	2
診斷與建議(Diagnosis and Suggestion).....	3
診斷說明(Disease Description).....	7
個人病史(Medical history).....	8
體格檢查(Physical Examination).....	9
檢驗室檢查(Blood and Laboratory Tests).....	11
10年心血管疾病風險評估(10-Year Risks of Atherosclerotic Cardiovascular Disease)	14
心肺檢查(Heart and Lung Studies).....	15
影像檢查(Image Studies).....	16
其他檢查檢驗項目(Other Exams).....	18

高雄榮總健康管理中心

Health Management Center at Kaohsiung Veterans General Hospital

地址:81362高雄市左營區大中一路386號

Address: No.386 Ta-Chung 1st RD, Kaohsiung, Taiwan 813 R.O.C

傳真Fax:886-7-3468357 / 電話Tel:886-7-3419187

<https://org.vghks.gov.tw/pcu/>

健檢光碟公告

感謝您選擇高雄榮民總醫院健康管理中心來為您做健康檢查服務。

本中心健檢報告不提供影像光碟片，倘若貴賓有健檢影像光碟片的需求，敬請至以下時間/地點提出申請(收費標準依據高雄市政府衛生局公告)：

週一至週五(正常上班日) 08:00 ~ 17:00

* 門診大樓一樓社區健康中心(客服中心對面)

電話:07-342-2121 分機75974

* 醫療大樓一樓住院服務中心(郵局旁)

電話:07-342-2121 分機75904

* 高齡大樓一樓收費櫃檯

電話:07-342-2121 分機75938

詳細資訊請至高雄榮民總醫院網站首頁<https://www.vghks.gov.tw/>

「就醫指引」→「申辦服務」→「病歷資料暨影像光碟複製申請」



健檢光碟申請



個人資料 (Personal Information)

病歷號 20598270

Hospital No :

房間號 PCU - 044

Room No :

姓名 葉興松

Name :

檢查日期 2025-10-29

Date of Examination :

性別 男

Gender : M

出生日期 1978-05-01

Date of Birth :

年齡 47歲5個月

Age : 47 years 5 month(s)

(1) 網址 : <https://org.vghks.gov.tw/pcu/>

(2) 高雄榮總掛號系統連結↓



網路掛號



Registration



綜合分析(Summary)						
專科分類		A	B	C	D	E
1	新陳代謝科(Endocrinology & Metabolism)	★				
2	心臟內科(Cardiology)		★			
3	胃腸肝膽科(Gastroenterology and Hepatology)		★			
4	家庭醫學科(Family Medicine)					★
5	眼科(Ophthalmology)					★
說明	A 該科有異常或疾病，請立即進一步檢查或治療 Need further evaluation and treatment.		  網路掛號 Registration			
	B 該科有異常或疾病，請定期回診追蹤治療 Please go to the Outpatient Department for a follow-up regularly.					
	C 該科有異常或疾病，有症狀者請回診追蹤或治療 Please go to the Outpatient Department for a follow-up if symptom develops.					
	D 報告結果有輕微變化，通常不影響該系統功能 We recommend a health examination as a follow-up.					
	E 無明顯異常 Normal					



診斷與建議

★請立即進一步檢查或治療

新陳代謝科

診斷：

甲狀腺左側腫大, 依理學檢查
甲狀腺兩葉結節, 最大在左葉, 依超音波

建議：

- ◆宜追蹤甲狀腺超音波檢查，並依醫師指示加做細針抽取細胞學檢查。
- ◆宜新陳代謝科門診進一步追蹤與檢查。



診斷與建議

心臟內科

診斷：

心雜音，依理學檢查

脈波傳導速度輕微偏高，表示心血管疾病風險增加，依動脈硬化檢測

總膽固醇偏高

輕度胰島素抗性

醣化血色素偏高

低密度脂蛋白偏高

體重過重

建議：

◆您的理想體重是 63至77公斤

◆建議控制好心血管疾病危險因子，如血壓，血糖，血脂肪或尿酸等。

◆必要時，宜作心臟超音波檢查。

◆宜減輕體重，規律運動及飲食控制。

◆宜3個月後追蹤空腹血糖及醣化血色素。

◆宜3個月後追蹤血脂肪分析。

◆若有症狀，如活動時會胸口悶、喘不過氣等症狀，應到心臟內科求診並安排其他的檢查。

胃腸肝膽科

診斷：

脂肪肝，依超音波

肝水囊泡，依超音波

建議：

◆請定期追蹤腹部超音波檢查。

◆宜胃腸肝膽科門診追蹤。

審核醫師：許喬琳 醫師

主治醫師 許喬琳



Diagnosis & Suggestions

★Need further evaluation and treatment

META

Diagnosis:

Goiter, by physical exam.

Thyroid nodule, larger than 1.5 cm, by sono

Suggestions:

◆Sonography and fine needle aspiration of thyroid gland is indicated.

◆Please go to the Metabolism & Endocrine Outpatient Department for further follow-up and evaluation.



Diagnosis & Suggestions

CV

Diagnosis:

Heart murmur, by physical exam.

Pulse Wave Velocity slightly higher, cardiovascular disease risk increases, by ABI

Hypercholesterolemia

mild insulin resistance

Elevated HbA1c

dyslipidemia

Over weight

Suggestions:

◆Your ideal body weight is from 63 to 77Kg.

◆Risk factors such as high blood pressure, diabetes mellitus (diabetes), and hyperlipidemia (high cholesterol) should be monitored closely.

◆Echocardiography should be done if necessary.

◆More exercise and less body weight are necessary. Please avoid high carbohydrate and high fat diet.

◆Please recheck fasting glucose and HbA1c 3 months later.

◆Please recheck lipid profile 3 months later.

◆If the symptoms such as tightness of chest or shortness of breath occur, a referral for other evaluations and treatment at the Division of Cardiology is recommended.

GI

Diagnosis:

Fatty Liver, by sono

Hepatic cyst, by sono

Suggestions:

◆Repeat abdominal sonogram regularly.

◆Please go to the Gastro-intestinal Outpatient Department for a follow-up.

Name of verifying doctor: CHIAO-LIN HSU



診斷說明(Disease Description)

心雜音

心雜音源自心臟血流混亂，產生逆流或渦流，使心壁或大血管產生振動所致，依其雜音大小聲，可能來自正常的功能性雜音或心臟瓣膜異常、心肌異常等等。宜遵從醫師建議，決定是否應再進一步追蹤。

甲狀腺結節

所謂甲狀腺“結節”係指在甲狀腺內有局部腫塊，大部份是單一腫塊，但有時是多發性腫塊的一部份。多發性結節在老年人雖然常見，但往往沒有症狀，而甲狀腺單一結節，大約佔全人口的5%。造成甲狀腺結節的原因很多，雖然惡性腫瘤佔的比例很少，但因為有此可能性，所以必須針對甲狀腺結節作出診斷，以治療其中的惡性結節。良性的甲狀腺結節每三至六個月要追蹤超音波與細針穿刺細胞學，只要結節大小未變化，繼續追蹤即可。

肝水囊泡

所謂「肝水囊泡」是指出現於肝臟內具有上皮細胞且充滿了液體的囊狀構造，多為良性且好發於右葉，極少部分為寄生蟲性感染所致，或可能是先天性膽道發育時殘存遺跡所造成，而年長性變化也是原因之一。一般不會對身體造成任何傷害，有10-15%的病人會有上腹不適或悶痛感，除非囊腫太大壓迫到附近的組織，或囊腫因外力或不明原因而破裂，或囊腫內出血及感染才需要進一步處理。

脂肪肝

脂肪肝顧名思義就是肝細胞裡堆積了過多的脂肪，也就是俗稱的「肝包油」。引起脂肪肝的原因最常見的是肥胖、糖尿病、酗酒、肝炎或服用藥物。肝細胞被脂肪浸潤有時會引起輕微的發炎反應，所以有些人的肝功能會異常。脂肪肝變成肝硬化的機會約3-5%，肝炎引起的脂肪肝最後進展成肝硬化的比例則多達20%。脂肪肝的治療主要須去除病因，平時要注意少油及低糖飲食，少喝酒並多運動。



個人病史(Medical history)

主訴

咳嗽, 頸部痛, 打鼾

過去病史

甲狀腺結節/囊腫, 大腸瘻肉, 脂肪肝, 胃或十二指腸黏膜下腫瘤

手術史

骨關節系統手術: 膝蓋

過敏史

無



體格檢查(Physical Examination)

身高(Height): 180.6 公分(cm)
 體重(Weight): 84.2 公斤(kg.)
 身體質量指數(BMI): 25.8 公斤/平方公尺(kg/m)
 體脂比率(Body Fat Ratio): 30.4 %(
 腹圍(皮尺測量)(Abdominal girth): 95 公分(cm)
 腰臀比(Waist-to-hip ratio): 1.01
 體溫(Temperature): 36.3 度(攝氏)(°C)
 脈搏(Pulse Rate): 74 跳/分(/min.)
 呼吸(Respiration Rate): 16 次/分(/min.)
 血壓 (Blood Pressure)
 左手血壓(Blood pressure Left): 121/68 毫米汞柱(mmHg)
 其他(Others): 毫米汞柱(mmHg)
 聽力(音叉)(Ear): 無明顯異常
 皮膚(Skin): 無明顯異常
 頭眼耳鼻喉(ENT): 無明顯異常
 頸部(Neck): 無明顯異常
 甲狀腺(Thyroid gland): 左側腫大

胸肺 (Chest & Lung)
 變形(Deformity): 無
 乳房(Breast): 無明顯異常
 腋下(Axillary): 無明顯異常
 肺部(Lungs): 清澈
 心臟 (Heart)
 心律(Rhythm): 規則
 心雜音(Murmur): 有
 腹部 (Abdomen)
 外觀(Shape): 球狀
 壓痛處(Tenderness): 無
 肝臟(Liver): 無明顯異常
 脾臟(Spleen): 無明顯異常
 肛門指診(Rectal digital Examination): 自請免檢
 四肢(Extremities): 無明顯異常
 神經系統檢查(Neurological Examination): 無明顯異常
 其他異常發現(Others): 無

視力檢查

視力(Vision): 戴眼鏡
 右眼(O.D.): 1.2
 左眼(O.S.): 1.2
 其他(Others):
 眼壓(I.O.P.):
 右眼(O.D.): 12毫米汞柱(mmHg)
 左眼(O.S.): 11毫米汞柱(mmHg)
 辨色力(Color sense): 無明顯異常

[註]理想體重範圍公式: 男性:[(身高-80)*0.7]±10%; 女性:[(身高-70)*0.6]±10%;



ID/姓名: 20598270 / 葉興松

身高: 180.6 cm 年齡: 47 歲 性別: 男性 測量日期/時間: 2025/10/29 13:42

身體組成分析

	數值	身體水份	軟組織量	脂肪量	體重
身體水份 (L)	43.0 (38.9 ~ 47.5)	43.0	54.5 (49.6 ~ 60.6)	58.6 (53.3 ~ 65.1)	84.2 (61.0 ~ 82.5)
蛋白質 (kg)	11.6 (10.7 ~ 13.1)				
礦物質 (kg)	4.0 (3.7 ~ 4.5)				
體脂肪 (kg)	25.6 (10.1 ~ 15.1)				

肌肉/脂肪分析

	標準以下	標準	標準以上
體重 [kg]	50 70 85 100 115 140 160 180 200 220 240 260 [%]	184.2	
骨骼肌肉量	70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 [%]	32.7	
脂肪量	40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 [%]	25.6	

肥胖分析

	標準以下	標準	標準以上
BMI (kg/m ²)	10.0 15.0 18.5 22.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0 55.0 60.0 [%]	25.8	
體脂肪百分比 [%]	5.0 10.0 15.0 17.5 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0 55.0 [%]	30.4	

腹部肥胖分析

	標準以下	標準	標準以上
腰臀比	0.75 0.90	1.01	
內臟脂肪程度	0 4 6 10 15	12	
內臟脂肪面積 (cm ²)	50 100	168	
內臟脂肪重量	4.2 kg	皮下脂肪重量	21.4 kg

區段性瘦肉分析

	低	標準	高
右手肌肉量 (kg)	70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 [%]	3.25	0.378
左手肌肉量 (kg)	70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 [%]	3.19	0.377
頸部肌肉量 (kg)	70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 [%]	25.69	0.371
右腿肌肉量 (kg)	70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 [%]	9.05	0.375
左腿肌肉量 (kg)	70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 [%]	8.99	0.376

身體水份分析

	標準以下	標準	標準以上
細胞內水	70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 [%]	26.9	
細胞外水	70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 [%]	16.1	
水腫指數	0.407 0.413	0.375	

綜合評估

身體類型	肥胖等級1
身體健康年齡	49 歲
基礎代謝率	1635 kcal
每日消耗總能量	2517 kcal
細胞重量	38.4 kg
身體健康評分	69 分

身體平衡評估

上半身(左/右)	☒ 平衡 ☐ 不平衡 I ☐ 不平衡 II
下半身(左/右)	☒ 平衡 ☐ 不平衡 I ☐ 不平衡 II

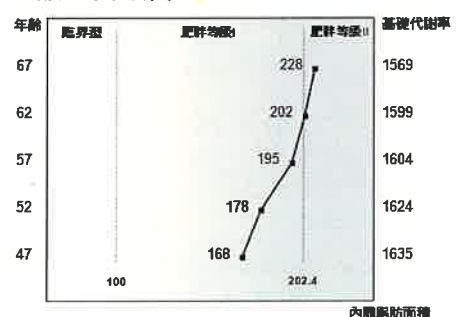
控制指南

目標體重	71.7 kg
體重控制	-12.5 kg
肌肉控制	+0.6 kg
脂肪控制	-13.1 kg

肥胖評估

BMI	☐ 體重不足 ☐ 標準 ☒ 體重過重 ☐ 肥胖
體脂肪百分比	☐ 低脂肪 ☐ 標準 ☐ 脂肪過多 ☒ 肥胖
肥胖度	+17.3 (-10.0 ~ +10.0) %
腹圍	100.9 (少於 85cm) cm

腹部肥胖預測圖



相位角: 5.1° (標準範圍: 6° ~ 8°)

阻抗係數 (625)

Freq	1K	5K	50K	250K	550K	1M
RA.Imp	361	353	316	285	275	269
LA.Imp	373	365	327	295	284	278
Trunk	30	29	26	22	20	18
RL.Imp	321	313	274	246	239	233
LL.Imp	327	318	279	251	244	238

Xc.

Freq	RA.Xc	LA.Xc	Trunk	RL.Xc	LL.Xc
50K	28	29	2	24	24

SMI: 7.50 kg/m³ (標準)
(Skeletal muscle mass index)



檢驗室檢查(Blood and Laboratory Tests)

檢查項目	本次	上次	前次	本次參考值
檢查日期	2025/10/29	2024/10/09	2023/10/26	
血液學檢驗				
血紅素(Hgb.):	14.8 g/dL	15.0	15.2	M:13.4-17.2;F:11.1-15.1;
血球比容(Hematocrit):	44.7 %	43.5	44.9	M:39.8-50.7;F:34.7-45.1;
紅血球(R.B.C.):	5.10 M/uL	5.04	5.15	M:4.3-6.0;F:3.8-5.1;
平均紅血球大小(M.C.V.):	87.6 fL	86.3	87.2	V:83.4-98.5;
平均血色素(M.C.H.):	29.0 pg	29.8	29.5	V:27.4-33.3;
平均血色素濃度(MCHC):	33.1 g/dL	34.5	33.9	V:32.1-35.2;
紅血球分佈寬度(RDW):	11.9 %	11.7	11.7	V:11.5-14.5;
白血球(W.B.C.):	6.07 K/uL	6.97	6.48	V:4.1-10.5;
嗜中性球(Neutrophils):	54.5 %	52.6	57.9	V:41.8-70.8;
淋巴球(Lymphocytes):	36.4 %	37.9	31.0	V:20.7-49.2;
單核球(Monocytes):	5.4 %	5.2	5.9	V:3.6-9.2;
嗜伊紅性球(Eosinophils):	3.0 %	3.4	4.6	V:<7.6;
嗜鹼性球(Basophils):	0.7 %	0.9	0.6	V:0.2-1.5;
血小板總數(Platelet Count):	277 K/uL	334	298	V:160-370;
其他一(Other1):				
其他二(Other2):				
肝臟功能檢驗				
膽紅素總量(Total Bilirubin):	0.7 mg/dL	0.6	0.7	V:0.3-1.5;
GO轉胺基酵素(SGOT):	23 U/L	21	28	V:13-39;
GP轉胺基酵素(SGPT):	37 U/L	36	47	V:0-40;
麩胺轉酸酵素(GGT):	31 U/L	27	32	V:9-64;
全蛋白(血)(Total protein):	7.3 g/dL	7.1	7.4	V:6.4-8.9;
白蛋白(Albumin):	4.6 g/dL	4.8	4.6	V:3.5-5.7;
腎臟功能與電解質檢驗				
尿酸(Uric Acid):	7.5 mg/dL	6.4	6.7	M:4.4-7.6;F:2.3-6.6;
尿素氮(B.U.N.):	10 mg/dL	11	9	V:7-25;
肌酸酐(Creatinine):	0.92 mg/dL	0.90	0.85	M:0.7-1.3;F:0.6-1.2;



檢查項目	本次	上次	前次	本次參考值
檢查日期	2025/10/29	2024/10/09	2023/10/26	
腎絲球過濾率(eGFR):	103.2 ml/min/1.73	90.8	97.5	
血清鈣(Serum Calcium):	9.1 mg/dL	8.9	9.2	V:8.6-10.3;
血清鈉(Sodium):	138 mmol/L	138	137	V:136-146;
血清鉀(Potassium):	3.7 mmol/L	3.8	4.1	V:3.4-4.5;
磷(Phosphate):	3.7 mg/dL			V:2.5-5.0;

新陳代謝及內分泌檢驗

空腹血糖值(Glucose):	90 mg/dL	94	88	V:70-100;
糖化血色素(Hb A1c):	5.8 %	5.9	5.7	V:<5.7;
C 胜肽胰島素(C-Peptide):	2 ng/mL			V:1.06-3.53;
胰島素阻抗(HOMA-IR):	1.42	2.07	2.48	V:<=1;
膽固醇總量(Total Cholesterol):	211 mg/dL	186	199	V:<201;
高密度脂蛋白(HDL-C):	56 mg/dL	48	45	V:>39;
低密度脂蛋白(LDL-C):	142 mg/dL	134	134	V:<130;
總量與高密度比(T.C./HDL-C):	3.8	3.9	4.4	V:<5.6
三酸甘油酯(Triglyceride):	125 mg/dL	140	203	V:<151;
甲狀腺刺激素放射免疫分析(HS-TSH):	0.87 uIU/ml	1.54	0.97	V:0.25-4.0;
游離甲狀腺素放射免疫分析(Free T4(NM)):	1.1 ng/dl	1.09	1.16	V:0.7-1.8;
睪丸激素(Testosterone):	3.12 ng/mL		4.64	V:2.4-7.16; (21-49yrs):2.4-8.71 ng/mL (≥50yrs):2.21-7.16 ng/mL

尿液檢驗

尿生化檢查(含潛血)(URINE BIOCHEMISTRY EXAM. + O.B.):

外觀一(APPEARANCE1):	黃色	黃色	黃色	
外觀二(APPEARANCE2):	清澈	清澈	混濁	
比重(CHEM:S.P.G.):	1.017	1.011	1.020	V:1.005-1.030;
酸鹼值(PH):	6.5	5.5	7.5	V:5.0-8.0;
尿蛋白(Protein):	-	-	-	V:-;
尿糖(Sugar):	-	-	-	V:-;
酮體(KET.):	-	-	-	V:-;
尿潛血(Occult blood):	-	-	-	V:-;
尿膽素原(URO.):	正常 E.U./dL	正常	正常	V:Normal;



高雄榮總健康管理中心

檢查項目	本次	上次	前次	本次參考值
檢查日期	2025/10/29	2024/10/09	2023/10/26	
尿膽紅素(BIL.):	-	-	-	V:-;
亞硝酸鹽(NIT.):	-	-	-	V:-;
白血球酯酵素(LEU.):	-	-	-	V:-;
尿沉渣顯微鏡檢查(Urine sediments):				
紅血球(R. B. C.):	0-2 /HP	0-2	0-2	V:0-2;
白血球及膿細胞(W. B. C.):	0-2 /HP	0-2	0-2	V:0-5;
上皮細胞(Epith):	0-5 /HP	0-5	0-5	V:0-5;
結晶體(CRYSTAL):				AMOR. PHOSP HATE:1+
外觀一(APPEARANCE1):	黃色	黃色	黃色	
外觀二(APPEARANCE2):	清澈	清澈	混濁	
其他(Others):				BACTERIA:1 +
肝纖維化指數				
肝纖維化指數(Liver fibrosis):	0.6			V:<=3.25



10年心血管疾病風險評估(10-Year Risks of Atherosclerotic Cardiovascular Disease)

您的 10年心血管疾病風險：2.2%

一般建議

- 建議養成健康的生活習慣，例如戒菸、維持規律的運動、低鹽、低油飲食

低密度膽固醇建議(標準值根據是否有不同共病而略有不同)

- 無冠狀動脈疾病、糖尿病、周邊血管疾病、中風的病人：130mg/dL以下
- 冠狀動脈疾病的病人：70mg/dL以下
- 急性心肌梗塞合併有糖尿病的病人：55mg/dL以下
- 周邊血管疾病病患：100mg/dL以下
- 缺血性腦中風病患：100mg/dL以下
- 頸動脈狹窄合併有症狀(例如頭暈)的病患：100mg/dL以下
- 糖尿病病患：70mg/dL以下
- 40歲以下糖尿病的病人，有心血管的危險因子(男性、高血壓、抽菸)：100mg/dL以下
- 當低密度膽固醇有達到治療標準後，會建議將三酸甘油酯保持在200mg/dL以下

血壓建議(標準值根據是否有不同共病而略有不同)

- 75歲以下，沒有糖尿病、冠狀動脈疾病、腎臟疾病的族群：140/90mmHg



心肺檢查(Heart and Lung Studies)

心電圖檢查(Electrocardiogram):

正常

SINUS RHYTHM
NORMAL ECG

動脈硬化檢測(ABI):

- 脈波傳導速度(PWV):
- 結果:輕微偏高
- 右側:1395(cm/s)
- 左側:1469(cm/s)

說明:

脈波傳導速度反應出動脈血管的彈性狀態。由上臂與腳踝脈波時間差與傳導距離，計算脈波傳導速度，當數值超過預期值越多表示動脈硬化程度愈明顯。

- 腳踝-手臂血壓比(ABI):
- 結果:
- 右腳踝-手臂血壓比:1.04, 正常
- 左腳踝-手臂血壓比:1.06, 正常

Ankle-brachial index --

Right Ankle-brachial index: 1.04
normal

Left Ankle-brachial index: 1.06
normal

Brachial-ankle Pulse Wave Velocity --

Right(cm/s): 1395

Left(cm/s): 1469

Slightly higher

Blood Pressure --

Right brachial blood pressure: 116, / 80, (mmHg)

Left brachial blood pressure: 126, / 81, (mmHg)

Right ankle blood pressure: 131, / 73, (mmHg)

Left ankle blood pressure: 133, / 75, (mmHg)



影像檢查(Image Studies)

上腹部超音波檢查(Sono, Upper abdomen):

- 輕度脂肪肝
- 肝水囊泡, 最大約 2 cm
- 膽囊、脾臟、腎臟、胰臟所見範圍無明顯異常病灶

Summary

Some abnormal findings, see below mentioned

Liver

Fatty liver mild degree

Liver cyst(s)

some, size up to 2 cm

GB

Normal

Spleen

Normal

Visible pancreas

Normal

Kidney

Normal



甲狀腺超音波檢查 (Sono, Thyroid gland):

- 甲狀腺兩葉結節, 最大在左葉, 約 2.6 cm
- 兩側頸部淋巴結

Report Template for Thyroid Ultrasound

Procedure: Ultrasound of thyroid

Clinical information: PCU

Impression

Abnormalities listed as follows:

Thyroid nodule(s) detected; FNA (fine needle aspiration) is suggested for the most suspicious one(s).

Observations

Thyroid

Grayscale ultrasound and Morphology

Normal size and echogenicity

Doppler ultrasonography normal vascularity

Detection of thyroid nodule(s) over Both lobes

Imaging Findings for the most prominent nodules:

Thyroid nodule details, #1:

*Recommendation for this node: FNA (fine needle aspiration) is suggested

*Based on Consensus criteria:

greater than 2 cm with mixed solid and cystic components

*Thyroid lobe laterality: Left

*Echogenicity: heterogeneously echogenic

*Color doppler ultrasound finding increased color coding

*Texture: mixed solid and cystic components

*Calcifications: no calcifications

*Size: 2.6 (cm in maximal axis dimension)

Cervical lymphadenopathy:

Bilateral neck lymph nodes with hila



其他檢查檢驗項目

次世代基因腸道菌叢分析檢測 (gut microbiota):

委外百歐精準生物醫學公司代檢

其他檢查(Others):

無

Nil

2-1. 檢測結果總覽

腸道健康指數：**78**

腸道年齡綜合分析



20至39歲

腸道年齡屬於青壯族群，請繼續維持。

腸型與飲食習慣分析



脂肪、蛋白質

脂肪、蛋白質為主的飲食類型，主要以動物、植物性蛋白或是油脂為飲食來源組成。

腸道益菌綜合分析

正常

有益菌在腸道中目前的佔比正常，可維持腸道菌群平衡。

腸道有害菌風險評估

高

腸道中有害菌分布比例偏高，極有可能對身體造成風險，請留意詳細的菌種分析報告。

有益菌協助合成維生素能力

正常

維生素B群為水溶性，人類無法從頭合成這些維生素，因此維生素B主要透過飲食提供，其餘則必須由腸道微生物合成。缺乏維生素B會導致認知功能障礙、神經病變、心血管疾病、骨質疏鬆等一系列疾病。

腸道菌參與短鏈脂肪酸合成能力

正常

短鏈脂肪酸是由腸道細菌在腸內發酵過程中產生的一種有機酸，而短鏈脂肪酸的含量高低與身體的抗發炎、胰島素的抗性、血清素的含量都有高度的關聯性。

腸道菌種多樣性分析

高

腸道內的菌群種類多樣性豐富，且各菌種的含量分佈較均勻，這樣的腸道比較能適應環境變化所造成的衝擊。

腸道菌豐富度綜合分析

高

代表腸道中被檢測到的菌種類數量高於該年紀大眾族群。需同時注意有益菌與有害菌種類數量之間相互比例關係。

整體評估結果為：尚可

腸道健康指數的分析標準會依據腸道中有益菌與有害菌的比例，及各種益菌所帶來的助益或是傷害，進行綜合演算所得到的結果。

2-2.總覽摘要說明

1. 受測者的腸道年齡為20到39歲腸齡偏向年輕。腸型屬於都會生活飲食型（普氏菌 = 2.29%，擬桿菌 = 18.29%），這類腸型大多食物攝取的來源為蛋白質或是油脂類組成，通常被認為是較不健康的腸道菌相。

[建議] 適度增加蔬果纖維、適量降低蛋白質攝取，盡量食用高品質的肉類來源（如魚肉）。降低油炸類食物攝取量或多增加富含Omega-3的油類補充，需要適時補充維生素、留意是否因為短鏈脂肪酸生成不足，造成情緒壓力過高而有失眠或是暴飲暴食的狀態。

2. 雙歧桿菌屬正常；乳桿菌屬偏低，整體有益菌組成正常。

[建議] 已經有『雙歧桿菌屬』定殖，但『乳桿菌屬』總量偏低，需要增加補充的菌量以及多攝取膳食纖維。

3. 菌種多樣性與豐富度偏高。

[建議] 腸道的菌群多樣性分布均勻而且組成的數量偏高，這樣更需要維持有益菌與有害菌的平衡性，一旦因為藥物或是補充的膳食纖維來源不足，造成有益菌大量降低豐富度，那腸道就可能會因為缺乏這些有益菌的制衡而讓有害菌大量增生，提高疾病風險指數。

4. 腸道中具指標性的防護類菌群分析中，艾克曼嗜黏蛋白菌(*Akkermansia muciniphila*，簡稱AKK菌)偏低。

[建議] 此類益生菌在腸道中具有控制醣類吸收與代謝的功能，加強腸道屏蔽的完整性，防止有害物質滲漏至血液中，進而改善慢性發炎的现象。如果缺乏該菌，請調整飲食與生活作息，同時增加腸道有益菌種類與數量，改變腸道的環境讓這類指標性有益菌利於定殖，建議調整後進行後測追蹤。

5. 有壞菌出現，困難梭菌為難治病菌，若有嚴重的反覆腹瀉腹痛等症狀，建議於胃腸科就診檢查。腸道沙門氏菌提高，請多留意飲食環境與調理食物過程的清潔。

[建議] 富含壞菌的變形菌門總量在警戒範圍，相關具指標性『致病原菌屬』總量偏高，需留意食材的新鮮度與料理方式，建議多食用抗菌類食材，如大蒜、辣椒、薑黃.....等。這些有害菌伺機潛伏在身體腸道中，有時候因為作息失調或飲食中無意攝取入過多的有害菌，讓這些菌快速生長後造成身體不適。請聽從醫師或個管師的建議進行相關深入的檢查。

6. 需注意當前菌相有誘發**肥胖**的風險，亦建議補充益生菌以恢復菌相平衡。

[建議] 可遵從醫師與個管師依據其他的健檢數據資料進行調整，並依據建議的修正內容執行後對自己的腸道健康做後測追蹤比較。

2-1.Detection result overview

Gut Healthy Score: **78**

Gut age analysis



Ages 20 to 39

Gut age falls within the young and middle-aged demographic. Please continue to maintain it.

Gut enterotype analysis



Protein & Fat

Characterized by fat and protein, this dietary type mainly comprises animal protein, vegetable protein, or grease.

Probiotics analysis

Normal

The current proportion of beneficial bacteria in the intestine is moderate, which can maintain the balance of the intestinal tract flora.

Harmful bacteria analysis

High

The proportion of harmful bacteria in the intestine is relatively high, which may be highly risky to the body. Please pay attention to the detailed bacterial analysis report.

Vitamin synthesis

Normal

The human body cannot synthesize vitamin B on its own; it must be obtained through diet and intestinal microorganisms. A deficiency in vitamin B can lead to cognitive impairment, nerve damage, heart disease, and osteoporosis.

SCFA synthesis

Normal

A short-chain fatty acid is an organic acid produced by intestinal bacteria during intestinal fermentation, which is highly correlated with factors in terms of anti-inflammation, insulin resistance, and serotonin content.

Diversity analysis

High

The gut microbiota is diverse with an even distribution of bacterial species, enabling better adaptation to environmental changes.

Richness analysis

High

It means that the number of detected bacterial species in the gut is higher than that of the general population in the same age group. It is important to also consider the balance between the number of beneficial and harmful bacterial species.

Overall Assessment: **Satisfactory**

The analysis criteria for the gut healthy score are based on the distribution ratio of probiotics and pathogen in the gut, as well as the benefits or harm brought by various bacteria. The comprehensive result is obtained through integrated calculations.

2-2. Abstract

1. The intestinal age of the subject is 20 to 39 years old, with a tendency towards a younger one. Their enterotype features belong to the urban diet type (*Prevotella* = 2.29 %, *Bacteroides* = 18.29 %.), whose food mainly comprises protein or fats, thus being considered less healthy intestinal microflora.

[Prescription]: It is recommended to increase the intake of fiber-rich fruits and vegetables, reduce protein intake moderately, and digest high-quality meat such as fish as much as possible. To reduce the intake of fried foods or increase the consumption of oil supplements rich in Omega-3, it is necessary to supplement with vitamins as needed and be mindful of the potential insufficient production of short-chain fatty acid, which may result in excessive emotional stress, further leading to insomnia or engorgement.

2. The levels of *Bifidobacterium* are normal, while the levels of *Lactobacillus* are low. Overall, the composition of beneficial bacteria is normal.

[Prescription]: *Bifidobacterium* are already present, but *Lactobacillus* levels are low. Increase probiotic intake and consume more dietary fiber.

3. The diversity and richness of bacterial species are high.

[Prescription]: The gut microbiota has a balanced diversity and a relatively high richness, making it even more important to maintain the balance between beneficial and harmful bacteria. If medication or insufficient dietary fiber intake leads to a significant reduction in beneficial bacteria, the lack of these beneficial bacteria may allow harmful bacteria to proliferate, increasing the risk of disease.

4. According to the analysis of specific protective bacterial flora in the intestine, there is a low presence of *Akkermansia muciniphila* (abbreviated as AKK).

[Prescription]: This kind of probiotic has the function of controlling carbohydrate absorption and metabolism in the intestine, strengthening the integrity of the intestinal shield, and preventing harmful substances from permeating into the blood, thereby improving the chronic inflammation. If this kind of probiotic is lacking, please adjust your diet and lifestyle, while increasing the variety and quantity of beneficial bacteria in the intestine. Improving the intestinal environment to facilitate the colonization of this specific beneficial bacteria is recommended. It is advised to conduct follow-up tests after the adjustments.

5. The pathogenic bacteria are elevated. *Clostridiodes difficile* is a kind of refractory bacteria. If you suffer severe symptoms such as recurrent diarrhea and abdominal pain, please visit a gastroenterologist for examination. *Salmonella enterica* is on the rise in volume. Please pay more attention to the cleanliness of the dining environment and cooking process.

[Prescription]: The overall count of potentially harmful bacteria from the phylum Proteobacteria is within the caution range. However, the number of specific pathogenic bacteria is above average. Paying attention to the freshness of ingredients and cooking methods is essential. And it is recommended to consume antibacterial foods such as garlic, chili peppers, turmeric, and so on. These harmful bacteria ambush the intestine. Sometimes, due to irregular routines or unintentional excessive intake of harmful bacteria in diet, these bacteria rapidly grow, causing discomfort. Please follow the physician's or nutritionist's advice and undergo relevant, thorough examinations.

6. It is important to note that the current microflora poses a risk of inducing **obesity**. It is also recommended to supplement probiotics to restore the balance of bacteria.

[Prescription]: You may follow the adjustments made by the physician and nutritionist based on other health examination data and make a post-treatment follow-up comparison of your intestinal health based on the recommended modifications.